Comprendre les adolescents

Un élève de 4e met plusieurs adultes à bout et un professeur exige son exclusion de cours. Comment comprendre ce qui se joue sans excuser ni diagnostiquer, et tenir le cadre sans humilier, quand les adultes eux-mêmes ne sont pas d'accord ?

La situation

Noah, 13 ans, est en 4e. En trois semaines, il a cumulé quatre fiches d'incident, surtout en français et en étude. Mme Roche, sa professeure de français, vous écrit qu'elle « ne le prendra plus en cours ». Antoine, AED, est catégorique : « Il le fait exprès. » Un autre AED a lu un article et pense que « c'est sûrement un TDAH ».

Pourtant, en EPS, Noah est décrit comme un élève moteur. Sa mère a demandé un rendez-vous. Le conseil de classe du premier trimestre approche, et l'équipe attend votre avis.

Les documents

N°	Document	Nature
1	Le message de Mme Roche	Messages
2	Les quatre fiches d'incident	Écrits professionnels
3	Le relevé de vie scolaire de Noah	Données
4	Ce que disent les adultes	Témoignages
5	Le courriel de la mère	Messages
6	Un article partagé en salle des professeurs	Article
7	Les compétences psychosociales	Ressource
8	Deux propositions dans la boîte du CPE	Messages
10	Ce que la recherche dit vraiment de l'adolescence	Ressource
11	Secret professionnel, secret partagé, aménagements	Ressource
12	Modèle de grille d'observation	Outil

N'ouvrez que les documents demandés par la consigne de l'étape. Les rebondissements ne figurent pas dans ce dossier : ils sont distribués au moment prévu.

Le message de Mme Roche

« Je ne prendrai plus Noah en cours. Il est insolent, provocateur, il cherche systématiquement l'affrontement et il détruit l'ambiance de la classe. Je demande une exclusion de mes cours jusqu'aux vacances. Il faut que la vie scolaire me soutienne. »

Les quatre fiches d'incident

Date	Lieu	Rédacteur	Texte de la fiche
8 sept.	Étude	Antoine, AED	« Noah est sorti trois fois sans autorisation. Comportement de défi permanent. »
15 sept.	Français	Mme Roche	« Insolence. A répondu "c'est bon, lâchez-moi" après une remarque. Provocateur. »
18 sept.	Étude	Antoine, AED	« A refusé de se rasseoir. Élève ingérable. »
22 sept.	Français	Mme Roche	« A claqué la porte en sortant. Attitude inadmissible, aucune envie de travailler. »

Le relevé de vie scolaire de Noah

- Absences : aucune. Retards : un.
- Passages à l'infirmerie : trois en septembre (lundi, jeudi, lundi).
- Changement de classe à la rentrée, à la demande de la famille.
- Bulletin de l'an dernier : « élève agréable, investi, doit gagner en confiance à l'écrit ».

Ce que disent les adultes

- **Mme Okafor, EPS :** « Noah est un moteur du groupe. Il aide les autres, il est capitaine de son équipe. Je n'ai aucun problème avec lui. »
- **Antoine, AED :** « Il le fait exprès, il teste. Il faut le casser tout de suite. »
- **Camille, AED :** « Avec moi, en étude, ça se passe bien quand je lui parle à part et que je lui montre ce qu'il doit faire. »
- **Le professeur principal :** « En maths ça va. Il décroche à l'écrit long. »

Le courriel de la mère

« Depuis le changement de classe, Noah dort mal et il a mal au ventre le dimanche soir. Il dit que certains profs l'ont "dans le viseur". Je voudrais comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas qu'il soit étiqueté. »

Un article partagé en salle des professeurs

« Le cerveau des ados n'est pas fini : voilà pourquoi ils sont insupportables » (magazine grand public, extrait reformulé).

L'article explique que le cortex préfrontal, siège du contrôle des impulsions, ne serait « mature qu'à 25 ans ». Il en conclut que « les ados ne peuvent pas se contrôler », qu'« il est inutile de leur demander de réfléchir avant d'agir » et que « les élèves qui provoquent ont simplement un cerveau en retard ».

Antoine l'a affiché au tableau de la vie scolaire.

Les compétences psychosociales

Santé publique France (synthèse reformulée, référentiel 2022). Les compétences psychosociales sont un ensemble de capacités qui permettent de faire face aux situations de la vie quotidienne. Elles se répartissent en trois catégories :

- **Cognitives :** avoir conscience de soi, maîtriser ses impulsions, prendre des décisions constructives.
- **Émotionnelles :** identifier ses émotions, les réguler, gérer son stress.
- **Sociales :** communiquer de façon constructive, développer des relations positives, résoudre des difficultés.

Elles se développent et s'apprennent, notamment à l'école, par des pratiques éducatives explicites.

Santé publique France, compétences psychosociales.

Deux propositions dans la boîte du CPE

D'un AED : « J'ai fait un test en ligne avec la description de Noah, ça ressort TDAH à 80 %. Il faudrait le dire à la mère pour qu'elle le fasse soigner. »

De Mme Benali, infirmière : « Noah est venu trois fois. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je pense qu'il faudrait que l'on se voie, avec la psychologue, pour réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour lui. »

Ce que la recherche dit vraiment de l'adolescence

Synthèse construite pour la formation, à partir des travaux de sciences cognitives sur le cerveau adolescent (par exemple ceux de Sarah-Jayne Blakemore et de B. J. Casey).

- **Le cerveau change beaucoup à l'adolescence**, et certaines régions situées à l'avant du cerveau, qui aident à planifier et à freiner une réaction, continuent de mûrir jusqu'au début de l'âge adulte.
- **Les adolescents sont, en moyenne, plus sensibles au regard des autres**, surtout des pairs, et à ce qui est vécu comme une humiliation ou une exclusion.
- **Ils savent se contrôler**, surtout quand la situation est calme. Le contrôle devient plus difficile sous le coup de l'émotion, devant le groupe ou quand ils se sentent mis en cause.
- **Le rythme du sommeil se décale** : beaucoup d'adolescents s'endorment plus tard et manquent de sommeil en semaine.
- **Ces résultats décrivent des moyennes de groupes.** Ils n'expliquent jamais à eux seuls le comportement d'un élève précis, et ils ne disent pas qu'un adolescent « ne peut pas » se contrôler.
- **Le contrôle de soi s'apprend**, avec des adultes qui donnent des consignes claires, expliquent les règles et évitent l'humiliation publique.

Un « neuromythe » est une idée fausse ou déformée sur le cerveau, qui circule comme si elle était scientifique.

Secret professionnel, secret partagé, aménagements

- **Le secret professionnel** : l'infirmière et la psychologue ne peuvent pas révéler ce qu'un élève leur confie ni ce qu'elles constatent sur sa santé.
- **Le secret partagé** : des professionnels qui accompagnent le même élève peuvent échanger les seules informations nécessaires pour l'aider, dans son intérêt, en informant la famille. Ce qui est partagé, c'est ce dont l'équipe a besoin pour agir (« éviter les remarques publiques »), pas le diagnostic.
- **Un document médical remis par une famille** lui appartient : l'établissement ne le photocopie pas pour le diffuser.
- **Les aménagements durables** passent par un dispositif écrit. En France : le PAP (plan d'accompagnement personnalisé, pour un trouble des apprentissages), le PAI (projet d'accueil individualisé, pour une maladie), le PPS (projet personnalisé de scolarisation, pour un handicap). Ils sont décidés avec la direction et sur avis médical.

Beaucoup d'établissements du réseau n'ont pas de médecin scolaire : la procédure d'aménagement se vérifie avec la direction.

Modèle de grille d'observation

À compléter avant de la confier aux AED pendant deux semaines. On n'y écrit que ce que l'on voit et entend.

Date et heure	Lieu	Ce qui était demandé à Noah	Ce que Noah a fait ou dit (mots exacts)	Ce que l'adulte a fait ou dit	Ce qui a suivi

À préciser : qui observe ; sur quels créneaux ; à qui la grille est remise et quand ; la date du bilan avec l'équipe.

Pas de case « attitude » ni « comportement » : ce sont des jugements. Pas d'information de santé.